

Prophylaxen-Kompodium



Alle examensrelevanten Prophylaxen mit Risikofaktoren, Assessment-Skalen, Maßnahmen und Expertenstandards – übersichtlich zum Lernen und Nachschlagen.

Bestehen ist planbar.

Expertenstandards

Assessment-Skalen

Hygiene

Examen

16

Themen

DNQP

Standards

A4

druckfertig

⚠ Lernhilfe für Ausbildung und Prüfung. Es gelten die Standards und Verfahrensanweisungen deiner Einrichtung.

Inhalt

Jedes Thema auf einer eigenen Seite – ideal zum Ausdrucken und Abheften.

01 Dekubitusprophylaxe

02 Sturzprophylaxe

03 Thromboseprophylaxe

04 Pneumonieprophylaxe

05 Aspirationsprophylaxe

06 Kontrakturprophylaxe

07 Intertrigoprophyllaxe

08 Obstipationsprophylaxe

09 Dehydrationsprophylaxe

10 Mangelernährungsprophylaxe

11 Infektionsprophylaxe / Hygiene

12 Stomatitisprophylaxe

13 Parotitisprophylaxe

14 Hygienische Händedesinfektion

15 Handschuhe – Wann ja, wann nein?

16 Allgemeine Krankenhaushygiene

1 Dekubitusprophylaxe

Maßnahmen zur Verhütung von Druckgeschwüren durch Druckentlastung, Hautpflege und Mobilisation.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettlägerigkeit
- Mangelernährung & Dehydration
- Inkontinenz / Feuchtigkeit
- Sensibilitätsstörungen
- Durchblutungsstörungen
- Hohes Alter

ASSESSMENT-SKALA

Braden-Skala

≤18 Punkte = Risiko · ≤12 = hohes Risiko · ≤9 = sehr hohes Risiko

- Sensorisches Empfindungsvermögen
- Feuchtigkeit
- Aktivität
- Mobilität
- Ernährung
- Reibung & Scherkräfte

KATEGORIEN / STADIEN

- Kat. I: Nicht wegdrückbare Rötung, Haut intakt
- Kat. II: Teilverlust der Haut (Blase/Abschürfung)
- Kat. III: Vollständiger Hautverlust, Subkutis sichtbar
- Kat. IV: Vollständiger Gewebeverlust, Knochen/ Sehnen sichtbar

MASSNAHMEN

- Lagerungswechsel alle 2 Stunden (oder individueller Plan)
- Antidekubitusmatratze / Wechseldruckmatratze
- Druckentlastung: Fersen, Steißbein, Schulterblätter
- Hautbeobachtung bei jeder Pflege (Rötung = Kategorie I)
- Hautpflege: pH-neutral, keine Massage bei Rötung
- Flüssigkeit mind. 1,5–2 l/Tag
- Proteinreiche Ernährung
- Inkontinenzversorgung optimieren
- Dokumentation nach Kategorien I–IV (EPUAP)

Standard / Grundlage: DNQP Expertenstandard Dekubitusprophylaxe (2017)

2 Sturzprophylaxe

Maßnahmen zur Verhinderung von Stürzen, besonders bei älteren und kognitiv eingeschränkten Patienten.

RISIKOFAKTOREN

- Gangstörungen, Gangunsicherheit
- Schwindel, orthostatische Hypotonie
- Seheinschränkungen
- Kognitive Beeinträchtigung / Demenz
- Polymedikation (Sedativa, Diuretika, Antihypertensiva)
- Frühere Stürze
- Inkontinenz (Dranggefühl)
- Unbekannte Umgebung

ASSESSMENT-SKALA

Morse-Sturzskala

0–24 = kein Risiko • 25–44 = mittleres Risiko • ≥45 = hohes Risiko

- Sturzvorgeschichte
- Sekundärdiagnose
- Gehhilfe
- IV-Zugang
- Gang
- Geistiger Zustand

MASSNAHMEN

- Rufanlage in Reichweite, Funktion erklären
- Bett auf niedrigste Position
- Orientierungslicht nachts
- Rutschfeste Schuhe / Socken
- Haltegriffe im Bad und WC
- Gehhilfen griffbereit
- Medikamente prüfen (Sedativa reduzieren?)
- Regelmäßiges Toilettenanbieten
- Sturzprotokoll nach Sturzereignis

Standard / Grundlage: DNQP Expertenstandard Sturzprophylaxe (2013/2019)

3 Thromboseprophylaxe

Vorbeugung tiefer Venenthrombosen durch physikalische und medikamentöse Maßnahmen.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettruhe
- Postoperativer Zustand
- Übergewicht (BMI >30)
- Dehydration
- Herzinsuffizienz
- Malignom
- Frühere TVT / LE
- Hormontherapie

WARNZEICHEN

- Wadenschmerz
- Schwellung
- Überwärmung
- Rötung
- Homans-Zeichen

MASSNAHMEN

- Frühmobilisation so früh wie möglich
- Kompressionsstrümpfe (ATS Kl. I/II) korrekt anlegen
- Intermittierende pneumatische Kompression (IPK)
- Beinübungen im Bett (Pumpen, Kreisen)
- Ausreichend Flüssigkeit
- NMH s.c. nach Anordnung (Clexane, Fragmin)
- Bei oraler Antikoagulation: INR / Anti-Xa überwachen

NOTFALLMASSNAHMEN

Lungenembolie: Dyspnoe + Tachykardie + Thoraxschmerz → SOFORT Arzt!

Standard / Grundlage: S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie (AWMF)

4 Pneumonieprophylaxe

Vorbeugung einer Lungenentzündung durch Sekretmobilisation, Atemübungen und Frühmobilisation.

RISIKOFAKTOREN

- Bettlägerigkeit
- Beatmung / Intubation
- Schluckstörungen
- Rauchen
- COPD, Asthma
- Immunsuppression
- Hohes Alter
- Schmerzen (verhindert tiefes Atmen)

MASSNAHMEN

- Atemgymnastik: tiefes Ein-/Ausatmen, Lippenbremse
- Atemstimulierende Einreibung (ASE) nach Bienstein
- Inzentiv-Spirometer (Flutter, Triflow)
- Sekretmobilisation: Abklopfen, Vibrationsmassage
- Oberkörperhochlagerung 30° (besonders bei Beatmung)
- Frühmobilisation: Sitzen → Stehen → Gehen
- Ausreichend Flüssigkeit (Sekret verflüssigen)
- Mundpflege (Keimreduktion)
- Schmerzmanagement

ATEMSTIMULIERENDE EINREIBUNG (ASE)

ASE: Kreisende Bewegungen am Rücken im Atemrhythmus des Patienten, 5–10 Min., fördert reflektorisch die Atemtiefe

5 Aspirationsprophylaxe

Verhütung des Eindringens von Speichel, Nahrung oder Mageninhalt in die Atemwege.

RISIKOFAKTOREN

- Schluckstörungen (Dysphagie)
- Bewusstseinsstörungen
- PEG / nasogastrale Sonde
- Erbrechen / Reflux
- Neurologische Erkrankungen
- Demenz
- Sedierung

MASSNAHMEN

- Oberkörper beim Essen 30–90° hochlagern
- Position 30 min nach Essen beibehalten
- Schlucktestung vor erster Mahlzeit
- Angedickte Kost / Flüssigkeiten
- Kein Strohhalm bei Schluckstörung
- Kleine Bissen, langsames Essen
- Absauggerät bereithalten
- Logopädie einbeziehen

6 Kontrakturprophylaxe

Verhütung von Gelenkversteifungen durch regelmäßige Bewegung und korrekte Lagerung.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Lähmungen
- Spastik (z.B. nach Schlaganfall)
- Schmerzen (Schonhaltung)
- Bewusstlosigkeit
- Frakturen / Verbände

MASSNAHMEN

- Passive Bewegungsübungen aller Gelenke (2× täglich)
- Korrekte Lagerung in Funktionsstellung
- Keine Spitzfußlage: Antispitzfußschiene / Fußstütze
- Handrolle bei Faustbildungstendenz
- Frühmobilisation
- Physiotherapie einbeziehen
- Schmerzen behandeln

LAGERUNGSTECHNIKEN

- Funktionsstellung: Gelenke in physiologischer Mittelstellung lagern
- Lagerung regelmäßig wechseln (Rücken-, Seiten-, 30°-Lagerung)
- Bei Hemiplegie: Lagerung nach Bobath-Konzept, betroffene Seite einbeziehen
- Füße: Fußsohle abgestützt, Bettdecke nicht auf die Zehen drücken lassen
- Lagerungshilfsmittel gezielt einsetzen, keine starren Dauerlagerungen

Standard / Grundlage: Kein eigener DNQP-Expertenstandard – Orientierung an Physiotherapie- und Bobath-Konzept

7 Intertrigoprophylaxe

Verhütung von Hautreizungen in Hautfalten durch Feuchtigkeit, Reibung und Wärme.

RISIKOFAKTOREN

- Übergewicht
- Diabetes
- Schwitzen
- Inkontinenz
- Immobilität

MASSNAHMEN

- Hautfalten täglich inspizieren (Achseln, Leisten, Bauch, Brust)
- Sorgfältig trocknen (Föhn auf niedrigster Stufe)
- Zinksalbe oder Cavilon-Spray
- Baumwolltücher zwischen Hautfalten
- Atmungsaktive Kleidung
- Bei Candidose: Nystatin-Puder

8 Obstipationsprophylaxe

Verhütung von Verstopfung durch Flüssigkeit, ballaststoffreiche Kost und Bewegung.

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität
- Geringe Flüssigkeitszufuhr
- Ballaststoffarme Ernährung
- Opioide / Anticholinergika
- Schilddrüsenunterfunktion
- Demenz

MASSNAHMEN

- Flüssigkeit mind. 1,5–2 l/Tag
- Ballaststoffreiche Kost: Vollkorn, Obst, Gemüse
- Körperliche Aktivität
- Bauchmassage im Uhrzeigersinn
- Warmes Getränk morgens (Gastrokolarer Reflex)
- Stuhlprotokoll führen
- Laxanzien nach AO: Macrogol, Lactulose, Bisacodyl
- Bei Opioidtherapie: prophylaktisch Laxans!

9 Dehydrationsprophylaxe

Verhütung von Flüssigkeitsmangel durch ausreichende Zufuhr und frühzeitige Erkennung.

RISIKOFAKTOREN

- Hohes Alter (Durstgefühl ↓)
- Demenz
- Schluckstörungen
- Fieber / Erbrechen / Durchfall
- Diuretika
- Hitze

WARNZEICHEN

- Trockene Schleimhäute
- Stehende Hautfalten
- Konzentrierter Urin (dunkelgelb)
- Tachykardie
- Hypotonie
- Verwirrtheit

MASSNAHMEN

- Trinkprotokoll führen (Ziel 1,5–2 l/Tag)
- Getränke in Reichweite stellen
- Alle 2h Trinken anbieten
- Lieblingsgetränke erfragen
- Ein-/Ausfuhr bilanzieren bei Risiko
- Suppe, Joghurt, Obst als Flüssigkeitsquellen
- Bei Dysphagie: angedickte Flüssigkeiten

10 Mangelernährungsprophylaxe

Verhütung von Unterernährung durch Ernährungsassessment und gezielte Maßnahmen.

ASSESSMENT-SKALA

MNA (Mini Nutritional Assessment)

≥ 24 = gut · $17-23,5$ = Risiko · < 17 =

Mangelernährung

MASSNAHMEN

- Gewicht wöchentlich kontrollieren
- Ernährungsprotokoll führen
- Appetitfördernde Maßnahmen: Lieblingsessen, Atmosphäre
- Kleine häufige Mahlzeiten
- Hochkalorische Trinknahrung (Fresubin, Ensure)
- Essen assistieren bei Bedarf
- Mundpflege (Schmerzen beim Essen?)
- Ernährungsberatung
- PEG bei dauerhafter oraler Unfähigkeit

11 Infektionsprophylaxe / Hygiene

Verhütung nosokomialer Infektionen durch konsequente Hygienemaßnahmen.

MASSNAHMEN

- Händehygiene: 5 Momente der WHO
- Hygienische HD: 30 Sekunden · Chirurgische HD: 3 Minuten
- Schutzausrüstung situationsgerecht: Handschuhe, Kittel, Maske
- Aseptisches Arbeiten bei Wundversorgung, Katheter, Infusionen
- Katheter: täglich Notwendigkeit prüfen (CAUTI-Prävention)
- Isolationsmaßnahmen bei MRSA, VRE, ESBL
- Reinigungs- und Desinfektionsplan einhalten

5 MOMENTE DER HÄNDEHYGIENE

- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten
- 3. Nach Kontakt mit infektiösem Material
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung

12 Stomatitisprophylaxe

Verhütung von Mundschleimhautentzündungen, besonders bei Chemo, Immunsuppression und Beatmung.

MASSNAHMEN

- Mundpflege 4–6× täglich (weiche Zahnbürste)
- Schleimhäute feucht halten (Mundspray, Glycerin)
- Keine alkoholhaltigen Mundspülungen
- Kamillentee / Salbeitee zum Spülen
- Bei Chemotherapie: Mundschleimhaut kühlen (Eiswürfel)
- Bei Soor: Nystatin-Suspension
- Lippen mit Fettsalbe pflegen
- Prothesen nachts herausnehmen und reinigen

13 Parotitisprophylaxe

Verhütung der Ohrspeicheldrüsenentzündung durch ausreichende Speichelproduktion und Mundpflege.

RISIKOFAKTOREN

- Dehydration
- Mundatmung
- NPO (Nahrungskarenz)
- Immunsuppression
- Anticholinergika

MASSNAHMEN

- Ausreichend Flüssigkeit
- Regelmäßige Mundpflege
- Kaugummi kauen (Speichelfluss ↑)
- Saure Drops (Speichelproduktion ↑)
- Mundatmung vermeiden: Nasenpflege
- Ohrspeicheldrüse beobachten (Schwellung, Schmerz)

14 Hygienische Händedesinfektion

Die hygienische Händedesinfektion ist die wichtigste Einzelmaßnahme zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Sie reduziert die transiente Keimflora auf ein sicheres Niveau (WHO, KRINKO 2016).

INDIKATIONEN

- 1. Vor Patientenkontakt
- 2. Vor aseptischen Tätigkeiten (Wundversorgung, Katheter, Infusion)
- 3. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material (Blut, Körperflüssigkeiten)
- 4. Nach Patientenkontakt
- 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung (Klingel, Bettgitter, Nachttisch)

DURCHFÜHRUNG

- Mindestens 3–5 ml alkoholisches Händedesinfektionsmittel entnehmen
- Einreiben mindestens 30 Sekunden (EN 1500)
- Schritt 1: Handfläche auf Handfläche reiben
- Schritt 2: Rechte Handfläche über linken Handrücken, wechseln
- Schritt 3: Handfläche auf Handfläche mit verschränkten Fingern
- Schritt 4: Außenseite der Finger durch Einschlagen
- Schritt 5: Daumen eingeschlossen in anderer Hand, wechseln
- Schritt 6: Fingerkuppen kreisend in Handfläche, wechseln
- Hände trocknen lassen – NICHT abwischen!

MASSNAHMEN

Creme

- Hände waschen NUR wenn sichtbar verschmutzt oder nach C.-difficile-Kontakt (Sporenbildner – Alkohol unwirksam!)
- Vor Desinfektion: Hände TROCKEN (feuchte Hände reduzieren Wirksamkeit)
- Handschuhe ersetzen Händedesinfektion NICHT
- Kein Schmuck, keine Uhren, keine langen Fingernägel, kein Nagellack
- Hautschutz: vor Dienst → Schutzpräparat · während Dienst → Pflegecreme · nach Dienst → rückfettende

HÄUFIGE FEHLER

- Zu wenig Desinfektionsmittel aufgetragen (verdampft zu schnell)
- Fingerkuppen und Daumen vergessen – häufigste Fehlerzone!
- Handschuhe abziehen ohne anschließende Desinfektion
- Hautschutz vernachlässigt → Hautschäden → Keimreservoir

Standard / Grundlage: WHO-Leitlinie Händehygiene 2009 · KRINKO-Empfehlung Händehygiene 2016 · EN 1500

15 Handschuhe – Wann ja, wann nein?

Handschuhe schützen Patient und Pflegende. Falscher Einsatz macht Handschuhe selbst zum Übertragungsweg. Sie ersetzen die Händedesinfektion NICHT.

MASSNAHMEN

HANDSCHUHE: WANN JA

HANDSCHUHE: WANN NEIN

- Nach jedem Handschuhwechsel: Händedesinfektion!
- Handschuhe direkt nach Gebrauch entsorgen – nicht in Taschen tragen
- Handschuhgröße wählen: zu eng → reißen · zu weit → rutschen
- Latexallergie: Nitril-Handschuhe verwenden
- Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten, Sekreten, Exkreten
- Kontakt mit Schleimhäuten oder nicht-intakter Haut
- Legen / Pflege von Gefäßzugängen, Kathetern, Drainagen
- Wundversorgung
- Kontakt mit kontaminierten Materialien (Verbände, Wäsche)
- Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Schutzhandschuhe)
- Isolationspflichtige Patienten (MRSA, VRE, Noro etc.)
- Normaler Patientenkontakt ohne Körperflüssigkeitskontakt (Begrüßung, Blutdruck messen)
- Medikamente richten ohne Kontaminationsrisiko
- Dauerhaftes Tragen ohne Indikation → Übertragungsweg + falsche Sicherheit

WARUM NICHT DAUERHAFT TRAGEN

- Handschuhe haben mikro-poröse Defekte – kein 100% Schutz
- Beim Aus-/Anziehen leichte Kontamination der Hände möglich
- Falsches Sicherheitsgefühl: Desinfektion wird vergessen
- Erhöhtes Übertragungsrisiko bei Wechsel ohne Händedesinfektion

HANDSCHUHTYPEN

- Untersuchungshandschuhe (Nitril/Latex): nicht-steril, allgemeiner Schutz
- Sterile OP-Handschuhe: aseptische Eingriffe, sterile Katheterisierung
- Haushaltshandschuhe: Reinigung und Flächendesinfektion
- Chemikalienschutzhandschuhe: Desinfektionsmittelkonzentrate

Standard / Grundlage: TRBA 250 (Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen) · KRINKO 2016

16 Allgemeine Krankenhaushygiene

Krankenhaushygiene umfasst alle Maßnahmen zur Verhütung nosokomialer Infektionen. Ca. 400.000–600.000 nosokomiale Infektionen jährlich in Deutschland, ca. 10.000–15.000 Todesfälle.

RISIKOFAKTOREN

- Liegekatheter (CAUTI-Risiko: täglich Notwendigkeit prüfen!)
- Gefäßzugänge (ZVK-assoziierte Sepsis)
- Beatmung (VAP)
- Postoperative Wundinfektionen
- Immunsupprimierte Patienten

MASSNAHMEN

Schlussdesinfektion

- Flächendesinfektion: täglich patientennahe Flächen (Bettgitter, Nachttisch, Klingel), nach Entlassung
- Wischdesinfektion: von rein nach unrein · von oben nach unten · Einwirkzeit beachten
- Abfall: Gruppe A (Hausmüll) · Gruppe B (infektiös) · Gruppe C (Zytostatika) · Sharpsafe für Nadeln
- Kanülen NIEMALS recappen – Nadelstichverletzungsgefahr!
- Infektionswäsche: roter Sack, direkt verschließen, nicht ausschütteln
- PSA anlegen: Kittel → Maske → Brille → Handschuhe
- PSA ablegen: Handschuhe → Kittel → Brille → Maske → Händedesinfektion

ISOLATIONSMASSNAHMEN

- MRSA: Einzelzimmer, Kittel + Handschuhe + FFP2
- VRE: Einzelzimmer, Kittel + Handschuhe
- Norovirus/C. difficile: Einzelzimmer, Händewaschen (kein Alkohol!), Kittel + Handschuhe
- Tröpfchen (Influenza, COVID): chirurgischer MNS oder FFP2
- Aerogen (TBC): Einzelzimmer mit Unterdruck, FFP3

MELDEPFLICHT

NRW

- Nosokomiale MRSA/VRE/ESBL-Infektionen: Meldepflicht §6/§7 IfSG
- Ausbrüche (≥ 2 Erkrankungen, epidemiolog. Zusammenhang): sofortige Meldung ans Gesundheitsamt
- Krankenhäuser: Surveillance-Pflicht nach §23 IfSG
- Schulungspflicht: mind. 1× jährlich

Standard / Grundlage: Infektionsschutzgesetz (IfSG) §23, §36 · KRINKO-Empfehlungen · Hygieneverordnung



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de